PARACETAMOL KABI IV RESUMEN AL PROFESIONAL

Paracetamol solución para infusión 10 mg/mL: 1 mL de solución contiene 10 mg de Paracetamol. Excipientes: Cisteína 0,1 mg/mL, manitol 36,7 mg/mL, agua inyectable. Cada vial de 100 mL contiene 1000 mg de Paracetamol. **Forma farmacéutica**: Solución para infusión. Indicaciones terapéuticas: Paracetamol kabi está indicado en: tratamiento rápido de dolor moderado, especialmente luego de una cirugía, en el tratamiento rápido de la fiebre, cuando por una necesidad se justifica clínicamente la administración intravenosa para tratar dolor y/o hipertemia, y/o cuando las demás vías de administración no son posibles.

PESO DEL PACIENTE	DOSIS DE ADMINISTRACIÓN	VOLUMEN DE ADMINISTRACIÓN	VOLUMEN MÁXIMO DE PARACETAMOL KABI IV SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN POR ADMINISTRACIÓN, BASADO EN LÍMITE SUPERIOR DE PESO (mL)***	DOSIS MÁXIMA DIARIA**
≤10 kg	7,5 mg/kg	0,75 mL/kg	7,5 mL	30 mg/kg, día
> 10 kg a ≤ 33 kg	15 mg/kg	1,5 mL/kg	49,5 mL	60 mg/kg, sin exceder 2 g
> 33 kg a ≤ 50 kg	15 mg/kg	1,5 mL/kg	75 mL	60 mg/kg, sin exceder 3 g
> 50 kg y factores de riesgo de hepatotoxicidad	1 g	100 mL	100 mL	3 g
> 50 kg y sin factores de riesgo de hepatotoxicidad	1 g	100 mL	100 mL	4 g

** **Dosis Máxima Diaria: La dosis máxima diaria presentada en la tabla es para aquellos pacientes que no están recibiendo otros medicamentos que contengan Paracetamol. En caso contrario estos valores deben ser ajustados para considerar estos medicamentos.**

*** **Pacientes con pesos menores requerirán menor volumen.** Intervalo mínimo entre administraciones debe ser por lo menos 4 horas. Intervalo mínimo entre administraciones para pacientes con daño renal severo debe ser por lo menos 6 horas.

Precaución: Evitar el error en la dosificación por confusión entre la dosis en miligramos (mg) y mililitros (mL), el que puede llevar a sobredosis accidental y muerte. Al prescribirlo, incluya ambos, dosis total en mg y el volumen total (mL). **Insuficiencia renal grave**: Se recomienda, cuando se administra Paracetamol a pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina <30 mL/min), aumentar el intervalo mínimo entre cada administración y reducir la dosis total diaria. **Adultos con insuficiencia hepatocelular, alcoholismo crónico, malnutrición crónica (bajas reservas de glutatión hepático), deshidratación**: La dosis máxima diaria no debe superar los 3 g. **Forma de administración**: Este medicamento es de un solo uso. Todos los restos de solución no utilizados deben desecharse. Antes de su administración el producto debe inspeccionarse visualmente para comprobar la ausencia de partículas o decoloración. La solución de Paracetamol se administra como una perfusión intravenosa durante 15 minutos. **Contraindicaciones**: Hipersensibilidad a la sustancia activa, Paracetamol hidrocloruro (profármaco del paracetamol) o cualquiera de sus excipientes, insuficiencia hepatocelular grave. **Precauciones y advertencias**: Se recomienda el uso de un adecuado tratamiento analgésico oral tan pronto como la vía de administración sea posible con el fin de evitar el riesgo de sobredosis, comprobar que otros productos medicinales administrados no contienen Paracetamol o el clorhidrato de paracetamol. Las dosis superiores a las recomendadas implican un riesgo de daño hepático grave. Los signos clínicos y síntomas de daño hepático (incluyendo hepatitis fulminante, insuficiencia hepática, hepatitis colestásica, hepatitis citolítica) generalmente no se observan hasta dentro de dos días y hasta un máximo de 4-6 días después de la administración. El tratamiento con antídoto debe administrarse tan pronto como sea posible. Paracetamol debe utilizarse con especial precaución en las siguientes circunstancias: insuficiencia hepatocelular (child-pugh: ≤9). Síndrome de gilbert meulengracht (ictericia familiar no hemolítica). Insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina ≤30 mL/min). Abuso crónico de alcohol. Desnutrición crónica (baja de las reservas de glutatión hepático). En pacientes que sufren de un origen genético de g-6-pd (favismo). La aparición de anemia hemolítica es posible debido a la asignación reducida de glutatión tras la administración de Paracetamol. Deshidratación. Efectos sobre las pruebas de laboratorio: Paracetamol puede interferir con los análisis de ácido úrico con ácido fosfotungstico y la pruebas de azúcar en la sangre con glucosa oxidasa-peroxidasa. **Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción**: Probenecid produce una reducción de casi 2 veces el aclaramiento de Paracetamol inhibiendo su conjugación con el ácido glucurónico. Debe considerarse la reducción de la dosis de Paracetamol en el tratamiento simultáneo con probenecid. La salicilamida puede prolongar la semivida de eliminación de Paracetamol. El metabolismo de Paracetamol puede verse disminuido en pacientes que tomen inductores enzimáticos como la rifampicina, barbituratos, antidepresivos tricíclicos y algunos antiepilépticos (carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona). Estudios aislados describen hepatotoxicidad inesperada en pacientes que toman alcohol o sustancias inductoras enzimáticas. La administración simultánea de Paracetamol y cloranfenicol puede prolongar la acción del cloranfenicol. La administración simultánea de Paracetamol y AZT (zidovudina) aumenta la tendencia a neutropenia. La administración simultanea de Paracetamol y anticonceptivos orales puede reducir el tiempo de vida de eliminación de Paracetamol. El uso concomitante de Paracetamol (4 g al día durante al menos 4 días) con anticoagulantes orales puede producir ligeras variaciones en los valores del INR. En este caso, se deben monitorizar los valores del INR tanto durante la administración como después de su interrupción. **Embarazo y lactancia**: Paracetamol únicamente debería ser utilizado en el embarazo tras una evaluación cuidadosa de la relación beneficio-riesgo. En este caso, la posología y la duración recomendadas deben observarse estrictamente. **Lactancia**: Después de la administración oral, Paracetamol se excreta en la leche materna en pequeñas cantidades. No se han comunicado efectos indeseables en niños lactantes. En consecuencia, Paracetamol se puede usar en mujeres durante la lactancia. **Reacciones adversas**: Como todos los medicamentos que contienen Paracetamol, las reacciones adversas son raras o muy raras. **Raras**: Enfermedades vasculares: Hipotensión. General y lugar de inyección: Malestar. Investigaciones: Aumento de transaminasas. **Muy raras**: Enfermedades de la sangre y el sistema linfático: Trombocitopenia, leucopenia, neutropenia, agranulocitosis. Enfermedades del sistema inmunitario: Hipersensibilidad (desde una simple erupción cutánea o una urticaria a shock anafiláctico, que precisan la suspensión del tratamiento), broncoespasmo. **Sobredosis**: Existe riesgo de lesión hepática (incluyendo hepatitis fulminante, fallo hepático, hepatitis colestática, hepatitis citolítica), particularmente en sujetos de edad avanzada, en niños pequeños, en pacientes con insuficiencia hepática, en casos de alcoholismo crónico, en pacientes que sufren malnutrición crónica y en pacientes que reciben inductores enzimáticos. En estos casos, la sobredosis puede ser fatal. **Síntomas de sobredosis**: Los síntomas aparecen generalmente en las primeras 24 horas e incluyen: náuseas, vómitos, anorexia, palidez y dolor abdominal. La sobredosis con una sola administración de 7,5 g o más de Paracetamol en adultos o una sola administración de 140 mg/kg de peso corporal en niños producen una necrosis celular hepática que probablemente inducirá una necrosis completa e irreversible, ocasionando insuficiencia hepatocelular, acidosis metabólica y encefalopatía que puede producir coma y a veces la muerte. Simultáneamente, se observa un aumento de los niveles de las transaminasas hepáticas (AST, ALT) del lactato deshidrogenasa y de la bilirrubina junto con una reducción del nivel de protrombina, que pueden aparecer en un intervalo de 12 a 48 horas tras la administración. Los síntomas clínicos de la lesión hepática suelen ser evidentes inicialmente después de dos días, y alcanzar un máximo después de 4 a 6 días. **Tratamiento de la sobredosis**: Hospitalización inmediata. Antes de iniciar el tratamiento, y tan pronto como sea posible después de la sobredosificación, tomar una muestra de sangre para analizar el nivel de Paracetamol en plasma. El tratamiento incluye la administración del antídoto, N-acetilcisteína (NAC), por vía intravenosa u oral, de ser posible durante las primeras 10 horas. La N-acetilcisteína puede aportar algún grado de protección incluso pasadas las 10 primeras horas; sin embargo, en estos casos, será necesario prolongar el tratamiento. **Tratamiento sintomático**: Deberán realizarse pruebas hepáticas al inicio del tratamiento y deberán repetirse cada 24 horas. En la mayoría de los casos, las transaminasas hepáticas vuelven a la normalidad en una a dos semanas con restauración plena de la función hepática. Sin embargo, en casos muy graves, puede ser necesario un trasplante hepático. La hemodiálisis puede disminuir la concentración en plasma de Paracetamol, pero los efectos son limitados. **Vida útil:** 36 meses. La estabilidad física y química una vez abierto el envase ha sido demostrada durante 6 horas a temperatura ambiente. Desde el punto de vista microbiológico, el producto se debe usar inmediatamente. Si no se usa inmediatamente, los tiempos y las condiciones de conservación en uso son responsabilidad del usuario y no deberán superar las 24 horas a una temperatura entre 2 y 8 °C, a menos que el método de apertura y almacenamiento tenga lugar en condiciones asépticas controladas y validadas. Si se diluye en una solución de 9 mg/mL de cloruro sódico (0,9%) o en una solución de 50 mg/mL de glucosa (5%), la solución también debe utilizarse inmediatamente. De todos modos, si la solución diluida no se utiliza inmediatamente, no debe guardarse durante más de 6 horas (incluido el tiempo de infusión). **Precauciones especiales de almacenamiento: No refrigerar o congelar. Compatibilidad**: Paracetamol solución para infusión 10 mg/mL puede diluirse en una solución de cloruro sódico 9 mg/mL (0,9%) o en una solución de glucosa 50 mg/mL (5%) hasta un décimo. La solución diluida debe ser inspeccionada visualmente y no debe utilizarse en caso de observarse opalescencia, partículas visibles o precipitadas. **Presentación:** Frasco ampolla de 100 mL. Caja por 10 unidades.

PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) 1 g/100 mL SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN. Registro Sanitario No. INVIMA 2013M-0014218.

FRESENIUS KABI

caring for life

Fresenius Kabi Colombia S.A.S.
Calle 99 # 10 - 19 Ofc. 701
Bogotá D.C. - Colombia
Tel.: (57 1) 7560404
Fax: (57 1) 7550529
Línea Gratuita Nacional
018000 18 KABI (5224)
www.fresenius-kabi.com.co